Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de São Pedro do Sul

Rua Ernesto Wagner, 233, 2º andar - Bairro: Centro - CEP: 97400000 - Fone: (55) 3029-9990 - Balcão Virtual: (55)9.9911-7542 - Email: frsaopedrovjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000468-88.2018.8.21.0129/RS

AUTOR: JOSE LUIZ PERES

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RÉU: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL / RS

SENTENÇA

I - Relatório

JOSE LUIZ PERES ajuizou *AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA* em desfavor do **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL** e do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, todos qualificados.

Narrou que é portador de RETOSSIGMOIDITE ULCERATIVA (CRÔNICA) (CID 10 - K51), de modo que necessita do uso do medicamento REMICADE AMPOLA 100mg (10 ML). Afirmou não dispor de condições financeiras ao custeio do tratamento na modalidade particular sem prejudicar a sua subsistência. Discorreu acerca dos fundamentos jurídicos aplicáveis ao caso. Pugnou pela concessão da AJG. Liminarmente, requereu que a parte ré fornecesse o tratamento prescrito. Postulou a procedência da ação com a confirmação do pedido formulado liminarmente. Juntou documentos (evento 3, PROCJUDIC1, fls. 02/21).

Determinada a avaliação do tratamento pelo DMJ (evento 3, PROCJUDIC1, fl. 22).

Sobreveio avaliação do DMJ, a qual foi favorável ao tratamento do requerente com o medicamento postulado (evento 3, PROCJUDIC1, fls. 27/29).

Recebida a inicial e deferida a AJG, foi deferido o pedido liminar e determinada a citação do réu (evento 3, PROCJUDIC1, fls. 30/32).

Citado, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL apresentou contestação (evento 3, PROCJUDIC1, fls. 48/50, e PROCJUDIC2, fl. 01). Preliminarmente, arguiu inépcia da petição inicial. No mérito, referiu que a assessoria técnica da procuradoria recomendou o fornecimento do medicamento. Afirmou que a dispensação do fármaco deve ser condicionada à realização de exames periódicos. Discorreu acerca do descabimento da fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do Estado quando a parte é representada pela Defensoria Pública. Requereu o acolhimento da preliminar. Subsidiariamente, pugnou que o fornecimento seja condicionado à apresentação de exames periódicos pelo autor. Juntou documentos.

Igualmente citado, o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL apresentou contestação (evento 3, PROCJUDIC2, fls. 04/11). Preliminarmente, discorreu acerca da necessidade de chamamento da União ao feito. No mérito, teceu considerações quanto às competências do SUS. Requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, requereu que seja condenada ao custeio de apenas 1/3 do tratamento e o fornecimento se dê conforme a Denominação Comum Brasileira (DCB). Juntou procuração e documentos.

Houve réplica (evento 3, PROCJUDIC2, fls. 42/50).

Afastadas as preliminares, foi determinada a intimação das partes para manifestarem-se acerca da pretensão probatória (evento 3, PROCJUDIC3, fls. 01/02).

O Estado do Rio Grande do Sul pugnou pelo redirecionamento do feito em face da União, nos termos do Tema 793, com a remessam dos autos à Justiça Federal (evento 3, PROCJUDIC3, fls. 10/12).

A parte autora requereu a alteração da dosagem da medicação, com o fornecimento de 800 mg do medicamento Infliximab, a cada 8 semanas (evento 3, PROCJUDIC3, fls. 13/14).

Em face da ausência de oposição pelos réus, foi deferido o pedido de alteração da dosagem (evento 3, PROCJUDIC3, fls. 25/26). No mesmo ato, foi indeferido o pedido do Estado de inclusão da União.

Declarada encerrada a instrução, (evento 3, PROCJUDIC3, fl. 28).

Diante da manifestação do Ministério Público (evento 3, PROCJUDIC3, fls. 30/31), foi determinada a intimação da parte autora para apresentar atestado médico completo e atualizado (evento 3, PROCJUDIC3, fls. 32/33).

Juntado atestado pela parte autora (evento 3, PROCJUDIC3, fls. 34/43).

O Ministério Público opinou pela procedência da demanda (evento 3, PROCJUDIC3, fls. 47/50, e evento 3, PROCJUDIC4, fls. 01/03).

Postulada nova alteração na dosagem do fármaco (evento 3, PROCJUDIC4, fls. 05/09).

O Estado do Rio Grande do Sul comprovou a alteração da dosagem do medicamento (evento 3, PROCJUDIC4, fls. 17/19).

Determinada a intimação da parte autora para inclusão da União no polo passivo da demanda (evento 17, DESPADEC1), o que foi atendido (evento 20, PET1).

Deferida a inclusão da União no polo passivo, foi reconhecida a incompetência deste juízo e determinada a remessa dos autos à Justiça Federal (evento 22, DESPADEC1).

A Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade passiva da União, determinando o retorno dos autos à Justiça Estadual (evento 40, SENT1).

Intimada, a parte autora juntou aos autos comprovantes de renda (evento 127, PET1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

II - Fundamentação

Não havendo nulidades a serem sanadas ou preliminares pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

Do mérito

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por **JOSE LUIZ PERES** contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL,** ante a necessidade da criança de fazer uso dos medicamentos REMICADE AMPOLA 100mg (10 ml), a cada 8 semanas, em razão de ser ser portador de Retossigmoidite Ulcerativa Crônica (CID 10 - K51).

A Constituição Federal, em seu art. 5º, caput, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu art. 6º, que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde e o dever do Estado. A Lei 8.080/90, em seu art. 2º, reiterou que a saúde é um direito fundamental do cidadão, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS – Sistema Único de Saúde - e incumbindo aos entes públicos a prestação de serviços de saúde à população.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, a se ofertada através de sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse passo, cumpre destacar que para atender a esse relevante direito fundamental, foi estabelecida a responsabilidade solidária dos entes federados, nos termos dos arts. 23, inc. II, e 196, ambos da CF, conforme decidido no Tema 793, nos autos do RE nº 855.178, com reconhecimento da repercussão geral:

> *"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".*

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em observância ao tema, reafirmou o entendimento no sentido de que não é vedado ao cidadão que exija o cumprimento da obrigação de qualquer um dos entes públicos, visto que solidariamente responsáveis.

Neste sentido:

> *DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA E TRATAMENTO CIRÚRGICO. PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E COM DIAGNÓSTICO DE SEQUELAS DE LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DECORRENTE DE ACIDENTE DE MOTO. DEVER DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS ENTES PÚBLICOS. REGRA DO ART. 196 DA CF-88. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MATÉRIA SOLVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 793). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS PARTICULARIDADES DE CADA PACIENTE. RELEVÂNCIA DOS INTERESSES PROTEGIDOS (VIDA E SAÚDE). POSSIBILIDADE. TEMA Nº 06 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSIDERADO E APLICADO. IMPUGNAÇÃO DOS CUSTOS DO TRATAMENTO E COBRANÇA DE VALORES QUE EXTRAPOLA O OBJETO DA LIDE. 1.* ***Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, diante da solidariedade existente entre os entes públicos no atendimento à saúde pública, tal como prevista no artigo 196 e seguintes da CF-88. Dever dos entes públicos de atendimento à saúde que não se limita ao disposto em listas administrativas. Regra disposta no artigo 196 da CF-88 que prevalece.*** *Reconhecimento da repercussão geral do tema pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 855.178 (Tema nº 793) com solução de mérito que desautoriza a tese do apelante. 2. Mérito: O autor, menor púbere, representado por sua genitora, carente de recursos financeiros, apresenta diagnóstico de sequelas de lesões no membro inferior esquerdo decorrente de acidente de moto e necessita ser avaliada por médico traumatologista e ser submetido a procedimentos cirúrgicos. Dever de custeio pelos entes públicos, uma vez que implementados os requisitos postos na legislação de regência. Superdireito à saúde que deve prevalecer sobre os princípios orçamentários e financeiros esgrimidos na defesa pelo ente público. Ausência de afronta aos princípios da independência e autonomia dos Poderes. Responsabilidade solidária de todos os entes gestores do SUS em nível nacional, regional e municipal. Fontes de custeio e questões orçamentárias e fiscais que não devem embaraçar o direito à vida e saúde. Tema nº 06 da repercussão geral do STF aplicado. 3. A prova dos autos amparada em laudos médicos e relatórios de atendimento de emergência hospitalar são suficientes para demonstrar a necessidade de tratamento do apelado. 4. Impugnação dos custos de tratamento pelo Estado e pretensão de cobrança de valores que entende terem sido pagos a maior que refogem ao objeto da presente lide. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70083532762, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 12-11-2020) (destaquei)*

Outrossim, o egrégio TJRS firmou o entendimento de que eventual pleito de ressarcimento formulado pelo ente público obrigado deve ser realizado na esfera administrativa ou por ação própria:

> *AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE (ECA E IDOSO). FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA. TEMAS 793 E 1234 DO STF. JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 500 DO STF. MÉRITO. TEMA 106 DO STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA NESTA INSTÂNCIA. 1. O entendimento desta Corte era no sentido de que todas as demandas em que se buscasse o fornecimento de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS se fazia necessária a inclusão da **União** no polo passivo. Contudo, o Ministro Gilmar Mendes, ao deferir parcialmente tutela provisória nos autos do RE 1366243 (Tema 1234), determinou que as demandas com sentença prolatada até a data da decisão (17/04/2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução. 1.1. Conquanto a tese firmada quando do julgamento do RE 657.718, Tema 500/STF, relativo à possibilidade ou não de o Estado fornecer medicamentos não registrados na ANVISA, preveja que "as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União", foi consignada exceção quanto aos produtos à base de canabidiol, isso em razão da existência de regulação permitindo a importação, a teor da Resolução 130/2016. Logo, considerando que no caso concreto a sentença foi prolatada antes de 17/04/2023, cumpre realizar análise do mérito. **2. O e. STF, ao julgar o Tema 793, reafirmou a competência solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos. Não há, pois, no caso em apreço, falar em ilegitimidade passiva da parte ré, em face do dever solidário de prestação, constitucionalmente estabelecido. Isso porque, ao mesmo tempo que otimizou o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, a Suprema Corte também reforçou a solidariedade dos entes federativos nas demandas de saúde. Ademais, o ressarcimento entre os entes federados reclama demanda própria. Jurisprudência desta Corte.** 3. Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 106, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso específico, a parte requerente comprovou o preenchimento de tais requisitos. 4. Sentença de procedência do pedido mantida nesta instância. Honorários advocatícios majorados conforme disposto no §11 do artigo 85 do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50014686820208210060, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 08-11-2023) (destaquei)*

O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade.

A prestação jurisdicional, todavia, não pode deixar de considerar a situação individualizada de cada caso.

Por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº 106, o STJ fixou a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No presente feito, conforme laudos médicos juntado (evento 3, PROCJUDIC1, fls. 14/15, e PROCJUDIC3, fls. 35/37), a parte autora é portadora de Retossigmoidite Ulcerativa Crônica (CID 10 - K 51) e necessita do fármaco Infliximabe na dosagem indicada:

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente JOSÉ LUIZ PERES é portador da enfermidade *(descrever)* RETOCOLITE ULCERATIVA, conforme CID nº K51.3.

Assim, necessita dos seguintes medicamentos: *(anotar o princípio ativo)* INFLIXIMABE 100mg

pelo período de USO CONTINUO.

O não uso dos medicamentos no tratamento da doença acarretará ao paciente as seguintes consequências: AGUDIZAÇÃO DA DOENÇA, EVOLUÇÃO PARA DISPLASIA COLONICA, NEOPLASIA COLORETAL E OBITO

(X) os remédios podem ser substituídos por similares ou genéricos. Por qual? JÁ PRESCRITO O GENÉRICO

( ) os remédios **NÃO** podem ser substituídos por similares ou genéricos. Por quê?

O(a) paciente deve, com URGÊNCIA, iniciar o tratamento com o(s) medicamento(s) ? (X) SIM ( ) NÃO. Por quê? PARA DOENÇA ATIVA COM RISCO DE HEMORRAGIA E SEPSE.

SANTA MARIA, 06 de ABRIL de 2018.

Assinatura e carimbo médico com CRM

ATESTADO

Atesto que o paciente José Luiz Peres encontra-se em acompanhamento do Serviço de Gastroenterologia – Hospital Universitário de Santa Maria, para tratamento médico da patologia CID K51 (Retocolite Ulcerativa) desde 1996.
Paciente em uso de mesalazina e metotrexate de longa data e permanece com crises de diarreia sanguinolenta e dor abdominal importante. Necessita de dose complementar de prednisona 20mg (corticoide) via oral para alivio sintomático durante crise. Medicação essa com efeitos colaterais importantes.
Paciente necessita iniciar infliximab 5mg/ml 4amp para indução (semana 0, 2 e 6) e manutenção 4amp a cada 8 semanas por tempo indeterminado visto a gravidade da doença e prevenção de complicações. Paciente sob risco de desenvolver megacólon tóxico, diarreia sanguinolenta e óbito.

Alexandre Theisen Fucher
MÉDICO
CRM-RS
22/06/18

Além disso, tanto a avaliação do DMJ (evento 3, PROCJUDIC1, fls. 27/29) quanto a avaliação da assessoria técnica da Procuradoria do Estado (evento 3, PROCJUDIC2, fls. 02/03) foram favoráveis à utilização do fármaco para o tratamento da patologia.

Por sua vez, a incapacidade da parte autora de custear o tratamento restou demonstrada pelos documentos juntados no decorrer da demanda (evento 3, PROCJUDIC1, fl. 11, e evento 127, COMP2 e COMP3).

Outrossim, o referido medicamento está registrado na Anvisa e faz parte do Elenco de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

Observa-se, portanto, que, na hipótese, estão presentes os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgamento do REsp n° 1.657.156/RJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n° 106 – STJ), quais sejam: comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o curso do medicamento prescrito; e existência de registro na Anvisa do medicamento.

Assim, comprovada a necessidade e urgência na utilização do insumo, imperioso responsabilizar os entes públicos demandados pelo seu fornecimento

Logo, a procedência da demanda é a medida que se impõe.

III - Dispositivo

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, **JULGO PROCEDENTE** a ação ajuizado por **JOSE LUIZ PERES** em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** e do **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL,** para fins de **CONFIRMAR a antecipação de tutela deferida (evento 3, DESPADEC1)** e, consequentemente, **CONDENAR** os réus ao fornecimento ou custeio do medicamento **INFLIXIMABE 10mg/ml (REMICADE AMPOLA 100mg)**, pela DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA [princípio ativo], por tempo indeterminado, enquanto comprovada a necessidade.

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da FADEP, verba fixada em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, tendo em vista a singeleza da ação e a ausência de dilação probatória.

De outra banda, deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de Taxa Única, eis que isenta, sendo devidas, tão somente, despesas, a teor do que prevê a Lei da Taxa Única e a Recomendação 04/2020-CGJ.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Agendada intimação via eproc.

Transitado em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **WALKYRIA MARIA ALVARES DOS PRAZERES C DE S C, Juíza de Direito**, em 14/01/2025, às 13:04:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10074821895v6** e o código CRC **6cb99b8a**.